SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
HOSPITAL DE SAN CARLOS
SERVICIO CIRUGIA HSC

FECHA: 17-11-2023

HISTORIAL DE EVOLUCIÓN

NOMBRE:	PRIMITIVA DEL ROSARI GENERAL AGUILERA	RUN:	5454733
SEXO:	FEMENINO	FECHA NAC:	1947-11-08
EDAD:	76 AÑOS,	PREVISION:	FONASA B

02-11-2023

GARCIA
FERIA RAUL
08:20

Historia Actual

DG:

1. QUISTE HIDATIDICOS PULMONARES Y HEPATICO
2. HERNIA HIATAL POR DESLIZAMIENTO
3. LEVE DERRAME PLEURAL DERECHO

Comentarios de Evolución

1ER DIA POP X OBSTRUCCION INTESTINAL
VOLVULO DE INTESTINO DELGADO
SE OBSERVA DECAIDA ,POCO COOPERADORA
AFEBRIL
ESTABKLE HDM
ASPIRACION X SONDA NASOGASTRICA 200 ML DE CONTENIDO BILIOSO
TA-175/100
FC-94
TEMP-36,2
SAT-92
E/F
ABDOMEN -LIGERAMENTE DISTENDIDO ,SENSIBLE ,SIN PERITONISMO ,HERIDA CUBIERTA X APOSITOS SECOS
RHA++
TR-ESFINTER TONICO AMPOLLA CON HECES DURAS
CLINICAMENTE ESTABLE
SE DECIDE RETIRO DE SONDA NASOGASTRICA E INICIAR TTO CRONICO HABITUAL

Plan

REPOSO ABSOLUTO
RETIRO DE SONDA NASOGASTRICA
REGIMEN CERO
INICIAR TTO CRONICO VO
S,GLUCOSADO 5-1500 ML + 2GR NACL + 1GR KCL X CADA 500 ML EV DIA
SSF 0,9-1000 ML + KETOROLACO 30 MG X CADA 500 ML EV DIA
KNT MOTORA Y RESP
CURACION DE LA HERIDA
USO DE FAJA ABDOMINAL

Indicaciones

CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 1 frasco cada 12 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS 1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
ENOXAPARINA AMPOLLA 40 MILIGRAMOS 1 ampolla cada 24 hrs. por 1 dias via SUBCUTANEA
Agregar

Información Familiar

03-11-2023

PATRICIO ALEXIS JARA VILLA
11:21

Historia Actual

EQUIPO DE CIRUGÍA
DG:

1. POP (2) LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS
2. PANCREATITIS AGUDA

Comentarios de Evolución

PACIENTE ESTABLE, REGULARES CONDICIONES
AFEBRIL, EUPNEICA, SIN APREMIO VENTILATORIO
POCO REACTIVA, CONSCIENTE PERO NO RESPONDE A ÓRDENES SIMPLES
DIURESIS (+), DEPOSICIONES (+++), GASES (+)
RÉGIMEN CERO ACTUALMENTE
EX FÍSICO:
- HIDRATADA, BIEN PERFUNDIDA
- CONSCIENTE, VIGIL, POCO REACTIVA, DESORIENTADA, SIN DÉFICIT MOTOR.
- TORAX SIMÉTRICO, SIN LESIONES APRECIABLES
- ABDOMEN DISTENDIDO, DOLOROSO A LA PALPACIÓN PROFUNDA, SIN MASAS, BLUMBERG (-), HERIDA LIMPIA Y SECA, RHA (+)

SE RESCATAN RESULTADO DE EXÁMENES QUE EVIDENCIAN ELEVACIÓN DE PCR ATRIBUIBLE A CIRUGÍA, ADEMÁS DE ELEVACIÓN DE LIPASA Y AMILASA, PERFIL HEPÁTICO NORMAL, SIN LEUCOCITOSIS. COMPATIBLE CON PANCREATITIS AGUDA. DÍA 1 DE SINTOMATOLOGÍA, CORRESPONDE TAC AP C/C MAÑANA

Plan

REPOSO
CONTROL CON TAC AP C/C MAÑANA AM
HIDRATACIÓN

Indicaciones

REPOSO RELATIVO
RÉGIMEN CERO
SUERO RINGER A 80 CC HORA EV
ANALGESIA
REPOSO
CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS
AVISAR EVENTUALIDAD

Medicamento	Indicacion	Hora	Funcionario
CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO	1 frasco cada 12 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 frasco cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS	1 frasco cada 24 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		
METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		
ENOXAPARINA AMPOLLA 40 MILIGRAMOS	1 ampolla cada 24 hrs. por 3 dias via SUBCUTANEA		
ONDANSETRON COMPRIMIDO 4 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA		

Información Familiar

No

06-11-2023

SOFÍA MACARENA SPANO TORRES
08:54

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

5° DIA POSTOPERATORIO
PACIENTE ESTABLE, CON HIPERTENSION SISTOLICA HABITUAL, AFEBRIL, EUPNEICA, SIN APREMIO VENTILATORIO POCO REACTIVA, DIURESIS (+), DEPOSICIONES (+), GASES (+) HACE DOS DIAS, ACTUALMENTE SIN DOLOR ABDOMINAL
EN RÉGIMEN CERO ACTUALMENTE. EL VIERNES 3-11-23 SE CONSTATA ELEVACIÓN Y DE LIPASA Y AMILASA, PERFIL HEPÁTICO NORMAL, SIN LEUCOCITOSIS.
EX FÍSICO:
ABDOMEN DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, INDOLORO, RHA (+), HERIDA OPERATORIA OK
TAC 4-11-23 NEUMOPERITONEO Y DISTENCION DE ASAS EN CONTEXTO QUIRURGICO RECIENTE, PANCREAS DE ASPECTO NORMAL

Plan

INICIAR REGIMEN
LEVANTAR
KNT R Y M

Indicaciones

REPOSO RELATIVO, LEVANTAR Y DEAMBULAR
RÉGIMEN LIQUIDO A TOLERANCIA
SUERO RINGER A 60 CC HORA EV
CEFRIAXONA 2 GR EV AL DIA
METRONIDAZOL 500 MG EV AL DIA
OMEPRAZOL 40 MG EV AL DIA
METOCLOPRAMIDA 10 MG EV C/8 HRS EV
CLEXANE 40 MG SC AL DIA
METAMIZOL 1 GR C/8 HRS EV
KNT R Y M
AGREGAR TTO CRONICO HABITUAL

Información Familiar

No

07-11-2023

Julio Alberto Zugbe Arroyo
06:07

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

6TO DIA POST OP
PULSO:101
PA:167/90
TEMP:36.9
ABDOMEN DISTENDIDO EN SU PORCION INFERIOR

Plan

ME IMPRESIONA QUE SE REVOLVULÓ

Indicaciones

REGIMEN CERO
SUERO GLUCOSALINO 1500
SE SOLICITA RX DE ABDOMEN SIMPLE
PRESENTAR A CIRUJANO TURNO PARA EVENTUAL REINTERVENCION

Información Familiar

No

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
19:29

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

Neurología Adultos: Inteconsulta
Antecedentes:
- Enfermedad de Parkinson avanzado. Diagnóstico hace 25 años.
Alergias:
- Sin antecedentes (-).
Esquema de tratamiento actual:
- Levodopa + benserazida (200/50 mg), 1 comp a las 07-09-11-13-15-17 - 1 1/2 (19) hrs.
- Prolopa HBS 100/25 mg, 1 cap a las 07 y 2 cap a las 21 hrs.
- Pramipexol 1 mg, 1 comp a las 07-13-19 hrs.
- Amantadina 100 mg 1 (07) - 1(19)

Paciente hospitalizada en relación a obstrucción intestinal, primera intervención el 01/11/23.
Cursa con persistencia de distención, se reinterviene el 07/11/23
Sin vía oral, para mantener tratamiento.
Se solicita IC para ajuste de tratamiento parenteral.

Indicaciones

Se sugiere:
- Iniciar con parche de Rotigotina 4mg/24h, posterior a una semana se podría aumentar dosis a 8mg/24 horas.
- En caso de reiniciar vía oral, se puede iniciar reducción de 4 mg/24h por semana.
- Control por especialidad en caso de necesidad.

Información Familiar

No

08-11-2023

GARCIA
FERIA RAUL
09:33

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

1ER DIA POP X REINTERVENCION X VOLVULO DE INTESTINO DELGADO RECURRENTE
ENFERMEDAD DE PARKINSON
SE OBSERVA DESORIENTADA ,INTRANQUILA
AFEBRIL
AHORA CON CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS
VENTILANDO BIEN
TA-181/106
FC-95
TEMP-36,6
SAT-96
E/F
ABDOMEN -LIGERAMENTE DISTENDIDO ,INDOLORO ,HERIDA QX CON BORDES AFRONTADOS .DRENAJE TUBULAR 100 ML SEROHEMATICO
RHA ABOLIDOS
SONDA NASOGASTRICA ESCASA

Plan

REPOSO ABSOLUTO
MANTENER SONDA NASOGASTRICA A CIADA LIBRE Y CUNATIFICAR PERDIDAS
S,GLUCOSADO 5-1500 ML + 2GR NACL + 1GR KCL X CADA 500 ML EV DIA
SSF 0,9-1000 ML +METAMIZOL 2GR X CADA 500 ML EV DIA
KNT MOTORA Y RESP
MONITORIZACION CONTINUA
CUIDADOS DEL DRENAJE Y CUANTIFICAR PERDIDAS
AGREGAR TTO CRONICO X SNG

Indicaciones

CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS 1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR

Información Familiar

No

09-11-2023

LEON RAUSSEO
HONEY
CAROLINA
08:40

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

hemodinamicamente estable fc 100 normotensa, con adecuada saturacion
afebril hidratada
inicio en la madrugada tto de parkinson con parches
cp sin apremio
abdomen menos distendido, no impresiona dolor, rh + en cuatro cuadrantes. aposito limpio y seco dren escaso gasto.
ayer se realizo angiotac descarto tep
lab pcr 38 na 151 k 3.7 cl 123 uremia 111
leuco 14400 seg 91%

Plan

retiro del dren
kine motora y resp
curación interdiaria
movilización c/2h
inicio de regimen oral con survimed + agua

Indicaciones

nutricion enteral por sng con survimed a 20ml/h + agua 1000 en 24h

Medicamento	Indicacion	Hora	Funcionario
CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO	2 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS	1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS	1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL		
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR		
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS	1/2 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL		

Información Familiar

No

10-11-2023

LEON RAUSSEO HONEY CAROLINA
09:04

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
EXAMENES DE CONTROL MAÑANA

Comentarios de Evolución

paciente hoy mas vigil, tolerando NE POR SNG
insomnio
hemodinamicamente estable
normocardica, normotensa, normotermica
afebril hidratada
cp sin apremio
abdomen aun menos distendido que ayer, no impresiona dolor, rh + aposito limpio
extremidades hipotroficas sin signos de tvp

Plan

kine motora y resp
curación interdiaria
movilización c/2h
inicio de regimen oral con survimed + agua
retomar tratamiento cronico por sng

Indicaciones

nutricion enteral por sng con survimed a 20ml/h + agua 1000 en 24h
tto cronico por sng
dar jalea por boca sentada sin temblor y bien despierta a tolerancia

Medicamento	Indicacion	Hora	Funcionario
CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO	2 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS	1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS	1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL		
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR		
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS	1/2 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL		

Información Familiar

No

13-11-2023

GARCIA
FERIA RAUL
10:43

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
NEUMONIA BASAL IZQUIERDA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
COLITIS X CLOSTRIDIUM DIFFICIL

Comentarios de Evolución

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES
AFEBRIL
AUN CON DEPOSICIONES LIQUIDAS
SIN DISNEA
ALIMENTANDOSE X SNG
ESTABLE HDM
TA-139/88
FC-83
TEMP-36,6
SAT-96
E/F
ABDOMEN -PLANO ,BLANDO ,DEPRESIBLE ,INDOLORO ,HERIDA QX AFRONTADA SIN SECRESIONES
RHA++
MP AUDIBLE DISMINUIDO EN EL PULMON IZQUIERDO
PACIENTE EN CONDICIONES DE MANEJO X MEDICINA X MULTIPLES PATOLOGIAS MEDICAS
POP FAVORABLE

Plan

NUTRICION ENTERAL X SNG CON SURVIMED A 20 ML/H+AGUA
KNT MOTORA Y RESP
TTO CRONICO X SNG
AISLAMIENTO X CONTACTO
MOVILIZACION CADA 2H
CURACION DE LA HERIDA
USO DE FAJA ABDOMINAL
MANEJO X MEDICINA

Indicaciones

METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 frasco cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS 1 frasco cada 24 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 3 dias via sng
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 ampolla cada 12 hrs. por 3 dias via INTRAMUSCULAR
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 3 dias via sng
QUETIAPINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 3 dias via sng
CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 3 dias via sng
PARACETAMOL 1 G/100 ML MATRAZ UNIDAD 1 matraz cada 8 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025% 1 frasco cada 6 hrs. por 1 dias via INHALATORIA
VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 1 ampolla cada 6 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA

Información Familiar

No

14-11-2023

Julio Alberto Zugbe Arroyo
07:04

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
NEUMONIA BASAL IZQUIERDA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
COLITIS X CLOSTRIDIUM DIFFICIL

Comentarios de Evolución

7MO DIA POST OP
PULSO:85
PA:143/96
TEMP:36.6
ABDOMEN MAS DEPRESIBLE
DEPOSICIONES+
EN AISLAMIENTO POR CLOSTRIDIUM

Indicaciones

REGIMEN POR SNG
KNT RESP Y MOTORA
CONTINUA CON IGUAL TTO
PREVENCION DE ESCARAS

Información Familiar

No

15-11-2023

GARCIA
FERIA RAUL
09:37

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
NEUMONIA BASAL IZQUIERDA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
COLITIS X CLOSTRIDIUM DIFFICIL

Comentarios de Evolución

SE OBSERVA EN MEJORES CONDICIONES GENERALES
AUN CON DIFICULTADES EN LA DEGLUCION
ALIMENTANDOSE X SNG
AFEBRIL
ESTABLE HDM
NO HA PRESENTADO DEPOSICIONES DIARREICAS
TA-146/81
FC-58
TEMP-36,5
SAT-96
E/F
ABDOMEN -PLANO ,BLANDO,DEPRESIBLE ,INDOLORO ,HERIDA QX AFRONTADO
RHA++
EVOLUCION POP FAVORABLE
ACTUALMENTE CON AISLAMIENTO X CLOSTRIDIUM ,DEBE CUMPLIR 7 DIAS CON ATB VO
POSIBLE ALTA CON HODOM DIA VIERNES

Plan

REGIMEN X SNG
KNT MOTORA Y RESP
TTO CRONICO
PREVENCION DE UPP
MOVILIZACION CADA 2H
EVALUACION X FONOAUDIOLOGIA
USO DE FAJA ABDOMINAL

Indicaciones

METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS 1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
QUETIAPINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
PARACETAMOL 1 G/100 ML MATRAZ UNIDAD 1 matraz cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025% 1 frasco cada 6 hrs. por 1 dias via INHALATORIA
VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 1 ampolla cada 6 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA

Información Familiar

No

16-11-2023

LEON RAUSSEO
HONEY
CAROLINA
08:54

Historia Actual

OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
NEUMONIA BASAL IZQUIERDA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
COLITIS X CLOSTRIDIUM DIFFICIL

Comentarios de Evolución

ESTABLES CONDICIONES GENERALES
ALIMENTANDOSE POR SNG
NORMOTERMICA, NORMOCARDICA, NORMOTENSA
SIN DEPOSICIONES DIARREICAS, MENOS TEMBLOR
CP SIN PREMIO VENTILATORIO
ABDOMEN PLANO ,BLANDO,DEPRESIBLE ,INDOLORO ,HERIDA OP SIN SECRECIONES NI SIGNOS DE INFECCION
Plan de Manejo
REGIMEN X SNG
KNT MOTORA Y RESP
TTO CRONICO
PREVENCION DE UPP
MOVILIZACION CADA 2H
EVALUACION X FONOAUDIOLOGIA
USO DE FAJA ABDOMINAL

Plan

AISLAMIENTO X CLOSTRIDIUM ,DEBE CUMPLIR 7 DIAS CON ATB VO
POSIBLE ALTA CON HODOM MAÑANA
REEVALUACION POR FONO PARA EVALUAR POSIBLE RETIRO DE SNG
RETIRO DE SONDA VESICAL
RETIRO DE CVC

Indicaciones

RETIRO DE SONDA VESICAL
RETIRO DE CVC

Medicamento	Indicacion	Hora	Funcionario
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS	1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS	1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL		
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR		
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL		
QUETIAPINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL		
CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL		
PARACETAMOL 1 G/100 ML MATRAZ UNIDAD	1 matraz cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025%	1 frasco cada 6 hrs. por 1 dias via INHALATORIA		
VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS	1 ampolla cada 6 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		

Información Familiar

No

CASTRO SALAZAR HORTENSIA CONCEPCION
12:04

Historia Actual

EVALUACIÓN POR MEDICINA
16 DIAS HOSPITALIZACIÓN
DIAGNOSTICOS:
OBSTRUCCION INTESTINAL
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA + ADHERENCIOLISIS 1-11-23
PANCREATITIS AGUDA EN REGRESION
NEUMONIA BASAL IZQUIERDA TRATADA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
COLITIS X CLOSTRIDIUM DIFFICIL

Comentarios de Evolución

ESTABLES CONDICIONES GENERALES
ALIMENTANDOSE POR SNG
NORMOTERMICA, NORMOCARDICA, NORMOTENSA
SIN DEPOSICIONES DIARREICAS, MENOS TEMBLOR
CP SIN PREMIO VENTILATORIO
ABDOMEN PLANO ,BLANDO,DEPRESIBLE ,INDOLORO ,HERIDA OP SIN SECRECIONES NI SIGNOS DE INFECCION
PACIENTE C/IC POR INFECCIÓN POR DIARREA X COSTRIDIUM DIFFICILE , ACTUALMENTE 5° DIA VANCOMICINA EV, SIN DIARREA DESDE EL 13, SEGUN REGISTRO
EXAMEN FISICO AFEBRIL, NORMOCARDICA , NORMOTENSA, EUPNEICA, SAT 94%, MESOCEFALA, CON SNG, LENGUA SABURRAL, TORAX SIN RETRACCIÓN, CORAZON RR EN 2 TSS, PULMONES SONORIDAD Y MV CONSERVADO CRUJIDOS BASALES ESCASOS A IZQUIERDA, ABDOMEN APOSITOS SECOS, METEORISMO, B.D.I, SNI VISCEROMEGALIA PALPABLE, SIN SIGNOS IRRIT PERIT., RHA NORMALES, EXTR EDEMA -, LEVE ESCARA SACRA G1
PACIENTE YA EVALUADA POR DR. CALC}DERON, QUIEN SUGIRIÓ COMPLETAR TTO AB CON VANCOMICINA VIA ORAL (SNG)125 MG C/6 HORAS POR 7-10 DIAS, SIN INDICACIÓN DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA.

Plan

AISLAMIENTO X CLOSTRIDIUM ,DEBE CUMPLIR 7 DIAS CON ATB VO
POSIBLE ALTA CON HODOM MAÑANA
REEVALUACION POR FONO PARA EVALUAR POSIBLE RETIRO DE SNG
RETIRO DE SONDA VESICAL
RETIRO DE CVC

Indicaciones

VANCOMICINA 500 MG 1/4 AMPOLLA C/6 HORAS VIA SNG U ORAL
RETIRO DE SONDA VESICAL
RETIRO DE CVC

Medicamento	Indicacion	Hora	Funcionario
METRONIDAZOL FRASCO 500 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 frasco cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
OMEPRAZOL FRASCO 40 MILIGRAMOS	1 frasco cada 24 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS	1 ampolla cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA		
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200 MILÍGRAMOS / 50 MILÍGRAMOS	1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL		
HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MILIGRAMOS / MINILITROS	1 ampolla cada 12 hrs. por 1 dias via INTRAMUSCULAR		
CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL		

QUETIAPINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MILIGRAMOS	1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
PARACETAMOL 1 G/100 ML MATRAZ UNIDAD	1 matraz cada 8 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA
BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025%	1 frasco cada 6 hrs. por 1 dias via INHALATORIA
VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS	1 ampolla cada 6 hrs. por 1 dias via ENDOVENOSA

Información Familiar

No

Impreso: 2023/11/17 12:23 pm
Pía Carolina Vasquez Moraga
18273557-4
ADMIN